جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : مديحه حسين خليل حسين
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عين شمس **العنوان :** //
رقم البطاقة : 26803140103849 **رقم التليفون :** 01140498581 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 14-03-1968 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: مديحه حسين خليل حسين
National ID: 26803140103849

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مديحه
حسين خليل حسين
٥٤ ش عبدالرحمن محمد - عقبلى عفت
عين شمس - القاهره

٢٦٨٠٣١٤٠١٠٣٨٤٩

JP2565545


٢٦٨٠٣١٤٠١٠٣٨٤٩ ٢٠٢٢/٠٩
حاصلة على دبلوم تجارة

انثى مسلمة متزوجة
محمد حسين السيد عبدالعال
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٩/٢٣

National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

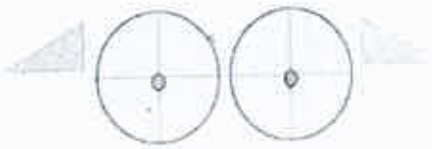
البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : منيحه حسين خليل حسين
Sex: Female
3- Medical number: 83170187
Old Med : 4071-2023

2-ID number:

Patient Age : 57 Y



Family history		Phone	01140498581	BMI		REASON OF MDT	
marital status		NRS Score		GROUP	3	Date of MDT	19/10/2024
Co morbidity	dm,htn	Menopausal status		Initial STAGE			

Clinical data

Breast Imaging :
LT diffuse skin thick mass + adenoma path axillary
RT : solid masses

Mets Workup :
CT CAP : FREE

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	0/8	0/8	-ve		60

T	N	M
RT T4B LT T4B	0 3C	

Sonomammography

PATIENT HISTORY
in 2017 rt BCS ,, adj CTR (AC / taxaanes), PORT , continued nolvadex x 5 ys
last MDT:FOR TAXOL CARBOPLATIN FOR 6 CYCLES & TO GET THE REPORT OF OLD TREATMENT FOR THI
BREAST CANCER IF RESPONDING CONSIDER BILATERAL MASTECTOMY
pt received NACT TC x12 wks last 22/6/2024
rt SM+LT MRM : rt partial response
lt partial response LN 1/11

MDT OUTCOME & PLAN

for bilat. PORT , Xeloda 6months after PORT
repeat IPT on residual
-consider BRCA testing

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Name: مديحه حسين خليل حسين **MR. :** 2338	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has bilateral breast cancer with right breast T4B N0 M0 and left breast T4B N3C M0. Neoadjuvant chemotherapy (NACT) was initiated in 2024. Bilateral mastectomy (BIL MRM) was performed in September 2025. Adjuvant therapy with XELODA has been started. The patient is currently on follow-up for BRCA testing, which has returned negative for breast and APUS mutations.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	
الطبيب المعالج :	هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر		

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / مديحه حسين خليل حسين		
Patient No.	: 26803140103849	Request No.	: 13008306
Path No.	: 2713/24	Request Date	: 03/08/2024
Sex	: Female	Verification Date	: 11/08/2024
Age	: 56 Y	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Referreing Doc	:	Department	: Out Patient
		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

CLINICAL DATA:
Bilateral breast cancer, post NACT.

Nature of specimen:
Right simple mastectomy specimen and Left MRM specimen.

Gross Examination:
1) Right simple mastectomy specimen measured 20x16x5 cm with covering skin ellipse measured 18x11 cm.
* Tumor extent: An ill defined grayish white and hemorrhagic tumor bed site.
* Size: 3.5 x 2.5x2 cm
* Skin involvement: Skin showing an old scar measured 8 cm long.
* Distance from margins: 2 cm away from deep margin and 2 cm away from the skin
There was an attached musle piece measured 6x6 cm.

2) Left MRM measured 21x16x5 cm with covering skin ellipse measured 18x13 cm.
* Tumor extent: An ill defined greyish white ruberry tumor bed site.
* Size: 11 x10 x3 cm.
* Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
* Distance from margins: 0.5 cm away from deep margin and 1.5 cm from the skin.
* Lymph nodes number and size: Axilla measured 8x6x2 cm. Axillary dissection entangling 10 L.Ns up to 3.5x3x2 cm.
There was one intramammary lymph node measured 1x0.8x0.5 cm.

MICROSCOPIC EXAMINATION:
1) Right breast ; simple mastectomy specimen:
Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+3+2) Grade III .

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / مديحه حسين خليل حسين	Request No.	: 13008306
Patient No.	: 26803140103849	Request Date	: 03/08/2024
Path No.	: 2713/24	Verification Date	: 11/08/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- (actual tumor size 3.5x2.5 cm), (cellularity 65%).
* Ductal carcinoma in situ: No.
* Lymphovascular emboli: Positive.
* Perineural invasion: No.
* Skin involvement: Free nipple and areola.
* Resection Margins: Free muscular margin.
* Histologic response to therapy: Partial pathological response.

2) Left Breast ; MRM specimen:
Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade III (3+3+2).
Actual tumor size 0.5x0.5 cm.
* Ductal carcinoma in situ: No.
* Skin involvement: Free nipple and areola.
* Resection margins: Free deep margin.
* Lymph nodes involvment: positive in (1/11). Maximal tumour in lymph node 7mm. One node showed therapy changes.
* Histologic response to therapy: Partial pathological response.

DIAGNOSIS:
1) Right breast ; Simple mastectomy specimen:
* Invasive duct carcinoma G III .
* Positive lymphovascular emboli.
* Free nipple and areola.
* Free muscular margin.
* Partial pathological response to therapy.
-Stage : ypT2.

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / مديحه حسين خليل حسين	Request No.	: 13008306
Patient No.	: 26803140103849	Request Date	: 03/08/2024
Path No.	: 2713/24	Verification Date	: 11/08/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

2) Left Breast ; MRM specimen:
* Invasive duct carcinoma G III.
* Free nipple and areola.
* Free deep margin.
* Lymph nodes were positive in (1/11). Maximal tumour in lymph node 7mm. One node showed therapy changes.
* Partial pathological response to therapy.
* Stage : ypT1, ypN1.
* Residual cancer burden: 3.10, RCB class II.

Signature

Prof.Lubna Omar.
Dr. Toqa Medhat.

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / مديحه حسين خليل حسين	Request No.	: 13002320
Patient No.	: 26803140103849	Request Date	: 11/11/2023
Path No.	: SR-1367/23	Verification Date	: 25/11/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 55 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Recurrent right Breast mass,left enlarged axillary lymph nodes.
Nature of Specimen: Slide revision.

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):(On Right breast and Left Axillary)
- ER: No nuclear reaction in the tumor cells (Allred score 0/8).
- PR: No nuclear reaction in the tumor cells (Allred score 0/8).
- Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
- Ki67: 60% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:
1- Right breast mass, Slide revision:
Invasive duct carcinoma, Grade III with focal necrosis.
2- Left axillary lymph node, Slide revision:
Metastatic carcinoma.

* IPT(On Right breast and Left Axillary):
- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 60% of tumor cells.

Verified by :
Rana fathy

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / مديحه حسين خليل حسين	Request No.	13002320
Patient No.	26803140103849	Request Date	11/11/2023
Path No.	SR-1367/23	Verification Date	25/11/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	55 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.			
		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

For (GATA3).

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature

Prof. Dr. Gamal Abdelaty

Dr. Marwa Mahmoud

Verified by :
Rana fathy

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Madiha Hussein Khalil Hussein	Date : 11/05/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 4071/2023	Pat. ID: 43990

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had right CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are almost entirely fatty (ACR A)
- Left diffuse skin thickening with no underlying lesions seen
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion d[illegible]
- right breast UIQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast UIQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with underlying well defined hypoechoic lesion with cystic contents measuring 3.8x1.3 cm, with no vascularity with color doppler study
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple areola complex.
- Left multiple pathological axillary lymph nodes seen in level I,III, the largest measuring 2.8x1.11 cm, showing diffuse cortical thickening and effaced hilum seen in level I
- No right pathological axillary lymph nodes

Opinion:

- right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with post operative fat necrosis. For follow up (BIRADS 3)
- still noted left pathological axillary lymph nodes as described above (BIRADS 6)

Yours truly

Signature Dr. Yasmin Nada

11/05/2024 11:32 AM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Madiha Hussein Khalil Hussein	Date : 11/11/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 4071/2023	Pat. ID: 43890

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. **Chest:**

- Diffuse skin thickening of left breast.
- Left axillary level I, II and III pathologically enlarged lymph nodes the largest one measures 3.5 x 3.5 cm with adjacent hypodense lesion measures 2.3 x 3.2 cm for US correlation
- Right breast distortion with heterogenous parenchyma and retro-areolar nodule measuring about 11x 9 mm
- No sizable pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No sizable pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. **Abdomen and pelvis:**

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal appearance of the pancreas, kidneys (apart from right renal gravel) aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Anterior abdominal wall large hernial defect with omental and bowel loop content.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- Gall bladder tiny stones .

- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Madiha Hussein Khalil Hussein	Date : 11/11/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 4071/2023	Pat. ID: 43890

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.
- First degree degenerative spondylolisthesis of L5

OPINION:

- ***Bilateral breast heterogenous density and left axillary pathological lymph nodes for US correlation.***
- ***No CT evidence of definite pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.***

Dr.Wafaa Ali, MSc.

Signature Prof. Menna Tallah Hanafy
13/11/2023 02:56 م

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECHON SUPPORT

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

تاريخ الاصدار :2023-11-1 جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 96 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التامينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) مديحه حسين خليل حسين بطاقة رقم 26803140103849

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتامين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :2023-11-1

الموظف المختص

اسلام عبد الحميد

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

مسلسل 1114551

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار الا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية او وزارة التضامن الاجتماعى او وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]